

Notions de sémantique médicale

Le vocabulaire de la sémiologie : du signe à la maladie

Pr M.A. CHAMI

Service de Médecine Interne — CHU d'Oran

Module de sémiologie générale · 3e année de médecine 2026/2027

Introduction

Sémantique et sémiologie : deux mots, une même racine

Sémantique

du grec *sêmantikos*, « qui signifie »

Étude du **sens des mots**. En médecine : signification précise des termes servant à décrire, nommer et classer les manifestations des maladies.

Sémiologie

du grec *sêmeion* (signe) + *logos* (discours, étude, raisonnement, science)

Étude des **signes des maladies** : comment les rechercher, les décrire, les regrouper et les interpréter.

En pratique

La sémantique médicale **précise le sens des termes utilisés en sémiologie** : elle fixe le vocabulaire que tous les soignants emploient.

Un même mot doit désigner la même chose pour tous : c'est la condition d'un raisonnement clinique rigoureux et d'une transmission fiable.

Trois disciplines complémentaires



Bien nommer, c'est déjà bien penser. Sans vocabulaire précis, il n'y a ni observation fiable ni raisonnement clinique rigoureux.

Decomposition d'un terme médical



Lire de la fin vers le début

gastrite = gastr- + -ite : inflammation de l'estomac.
cholécystectomie = cholécyst- + -ectomie : ablation de la vésicule biliaire.

La voyelle de liaison « o »

Elle relie deux racines : **hépatomégalie** (hépat-o-mégalie), **gastro-entérite** (gastr-o-entérite), **cardiopathie** (cardi-o-pathie).

Les racines : organes et tissus

Racine	Sens	Exemple
cardi(o)-	cœur	cardiomégalie
hépat(o)-	foie	hépatite
néphr(o)-, rén-	rein	néphropathie
gastr(o)-	estomac	gastrite
entér(o)-	intestin grêle	entérite
col(o)-	côlon (gros intestin)	colectomie
pneum(o)-	poumon	pneumopathie
chol(e)-	bile	cholestase

Racine	Sens	Exemple
cyst(o)-	vessie, vésicule	cystite
neur(o)-	nerf	neuropathie
encéphal(o)-	encéphale	encéphalite
dermat(o)-	peau	dermatose
ost(é)o-	os	ostéoporose
arthr(o)-	articulation	arthralgie
my(o)-	muscle	myalgie
hém(at)o-, -émie	sang	hématurie

Les préfixes : quantité, qualité, position

a-, an-

absence, privation

anurie, aphasie

dys-

difficulté, anomalie

dyspnée, dysphagie

hyper- / hypo-

excès / insuffisance

hypertension, hypoglycémie

poly- / oligo-

nombreux / peu

polyurie, oligurie

tachy- / brady-

rapide / lent

tachycardie, bradycardie

macro- / micro-

grand / petit

macrocytose, microcytose

hémi- / para-

**moitié / à côté (paraplégie :
deux membres inférieurs)**

hémiplégie, paraplégie

**endo- / péri- /
épi-**

dedans / autour / sur

*endocardite, péricardite,
épiderme*

Les suffixes : nommer ce qui ne va pas

-ite

inflammation — appendicite, arthrite

-ose

affection, processus souvent chronique ou dégénératif — arthrose

-ome

tumeur ou masse, bénigne ou maligne — adénome, lipome

-algie

douleur — névralgie, myalgie

-pathie

maladie (sans précision) — neuropathie

-mégalie

augmentation de volume — splénomégalie

-émie

présence dans le sang — glycémie, urémie

-urie

présence dans l'urine — protéinurie

-rragie

écoulement de sang — hémorragie, ménorragie

-rrhée

écoulement, flux — diarrhée, rhinorrhée

-pénie

diminution — leucopénie, thrombopénie

-plégie

paralyse — hémiplégie, tétraplégie

Les suffixes : nommer les actes et les examens

Explorer

- **-scopie** : examen visuel direct (endoscopie, coloscopie)
- **-graphie** : technique d'enregistrement ou d'image (échographie) ; **-gramme** : le résultat obtenu (électrocardiogramme)
- **-centèse** : ponction (paracentèse, thoracentèse)

Ouvrir, enlever, aboucher

- **-tomie** : incision (laparotomie)
- **-ectomie** : ablation (cholécystectomie, gastrectomie)
- **-stomie** : abouchement à la peau ou entre deux organes (colostomie)

Réparer, traiter

- **-plastie** : réparation, remodelage (angioplastie)
- **-lyse** : destruction, dissolution (thrombolyse)

Exercice

Hépatosplénomégalie

hépat(o) + splén(o) + -mégalie

→ *augmentation de volume du foie et de la rate*

Cholécystite

cholécyst- + -ite

→ *inflammation de la vésicule biliaire*

Hématurie

hémat + -urie

→ *présence de sang dans les urines*

Bradycardie

brady- + cardi- + -ie

→ *ralentissement du rythme cardiaque*

Dysphagie

dys + phag (manger) + -ie

→ *difficulté à avaler*

Leucopénie

leuc(o) (blanc) + -pénie

→ *diminution des globules blancs*

Symptôme ou signe ?

Symptôme

- **Subjectif** : ressenti par le patient
- Rapporté lors de l'**interrogatoire**
- Recueilli à l'interrogatoire, il constitue un **signe fonctionnel**
- *Ex. : douleur, nausée, prurit, vertige, palpitations*

vs

Signe

- **Objectif** : constaté par le médecin
- Mis en évidence par l'**examen**
- Signe physique, général ou paraclinique
- *Ex. : fièvre mesurée, hépatomégalie, souffle cardiaque*

Au sens large, « signe » désigne toute manifestation de la maladie. **On décrit des signes fonctionnels, physiques, généraux et paracliniques.**

Les quatre catégories de signes

Fonctionnels

- **Recueil** : interrogatoire
- Ce que le patient ressent et rapporte
- *Douleur, dyspnée, toux, dysurie*

Physiques

- **Recueil** : examen clinique
- Ce que le médecin voit, palpe, percute, ausculte
- *Ictère, matité, souffle, œdème*

Généraux

- **Recueil** : constantes, état général
- Retentissement global sur l'organisme
- *Fièvre, amaigrissement, asthénie*

Paracliniques

- **Recueil** : examens complémentaires
- Biologie, imagerie, explorations, histologie
- *Hémoglobine basse, opacité radiologique*

Signes physiques : les quatre temps de l'examen

1

Inspection

Regarder

Coloration (pâleur, ictère, cyanose), déformations, cicatrices, mouvements respiratoires

2

Palpation

Toucher

Masse, organomégalie, sensibilité, frémissement, pouls, œdème prenant le godet

3

Percussion

Tapoter

Sonorité normale, matité (liquide, organe plein), tympanisme (air)

4

Auscultation

Écouter

Bruits du cœur, souffles, murmure vésiculaire, râles, bruits hydro-aériques

Signes généraux : le retentissement sur l'organisme

Les constantes

- Température
- Fréquence cardiaque (pouls)
- Pression artérielle
- Fréquence respiratoire
- Saturation en oxygène (SpO₂)
- Poids, taille, indice de masse corporelle
- État de conscience (score de Glasgow)

Altération de l'état général (AEG) : les « 3 A »

Asthénie : fatigue anormale, non soulagée par le repos

Anorexie : perte d'appétit (≠ anorexie mentale)

Amaigrissement : perte de poids involontaire, à quantifier

Fièvre : un signe général distinct de l'AEG

En pratique, température ≥ 38 °C au repos ; le seuil varie selon le site et la méthode de mesure. Préciser l'évolution et les frissons.

Signes paracliniques : « à côté » de la clinique

Biologie

Sang, urines, liquides de ponction (LCR, liquide pleural, ascite)

Imagerie

Radiographie, échographie, scanner, IRM, scintigraphie

Explorations fonctionnelles

ECG, épreuves fonctionnelles respiratoires, EEG, EMG

Endoscopie

Visualisation directe des cavités (fibroscopie, coloscopie)

Anatomopathologie

Étude des tissus prélevés (biopsie) : peut apporter le diagnostic de certitude, notamment en pathologie tumorale

Les examens paracliniques **confirment ou infirment** une hypothèse clinique : ils ne la remplacent pas.

Analyser un symptôme : l'exemple de la douleur

Une douleur mal décrite est une douleur mal comprise.

Ces 7 questions s'appliquent à tout symptôme.

1

Siège

Localisation précise, montrée avec le doigt

2

Irradiation

Trajet de propagation

3

Type

Brûlure, constriction, torsion, coup de poignard, pulsatile

4

Intensité

Échelle visuelle analogique ou numérique de 0 à 10

5

Début et durée

Brutal ou progressif ; permanent ou intermittent

6

Facteurs modifiants

Déclenchants, aggravants, calmants (effort, repas, position)

7

Signes associés

Fièvre, vomissements, dyspnée...

Tous les signes n'ont pas la même valeur

Non spécifique

Rencontré dans de nombreuses maladies ; oriente peu.

Ex. : fièvre, asthénie

Évocateur

Fait suspecter fortement une affection.

Ex. : douleur thoracique constrictive à l'effort → angor

Pathognomonique

À lui seul, signe une maladie précise.

Ex. : signe de Koplik → rougeole

Signe de gravité

Témoigne d'un danger immédiat ; impose une prise en charge urgente.

Ex. : purpura fébrile extensif, état de choc



spécificité croissante

Signes positifs et signes négatifs

Signe positif

Signe **recherché et présent**.

Patient fébrile et céphalalgique : raideur de nuque présente

Signe négatif

Signe **recherché et absent** : il doit être noté. Une absence non recherchée n'est pas un signe négatif.

Même patient : absence de purpura, absence de déficit neurologique

Ce qui n'est pas écrit dans l'observation est considéré comme non recherché. Notez les signes négatifs pertinents.

Les signes éponymes

Signe de Murphy

Arrêt de l'inspiration à la palpation de l'hypochondre droit

→ **Cholécystite aiguë**

Signe de Blumberg

Douleur provoquée ou majorée à la décompression brusque de la paroi (classiquement fosse iliaque droite)

→ **Irritation péritonéale**

Signe de Babinski

Extension lente du gros orteil à la stimulation plantaire

→ **Atteinte pyramidale**

Signe de Lasègue

Douleur radiculaire à l'élévation de la jambe tendue

→ **Sciatique**

Signe de Kernig

Flexion des genoux lors de la flexion des cuisses sur le bassin

→ **Syndrome méningé**

Signe de Brudzinski

Flexion des membres inférieurs à la flexion de la nuque

→ **Syndrome méningé**

Signe de Chvostek

Contraction de la lèvre supérieure à la percussion de la joue

→ **Hypocalcémie**

Signe de Trousseau

« Main d'accoucheur » sous brassard gonflé (≠ syndrome de Trousseau)

→ **Hypocalcémie**

Qu'est-ce qu'un syndrome ?

Syndrome : ensemble de signes et de symptômes survenant ensemble, relevant d'un même mécanisme physiopathologique, sans préjuger de la cause.

Plusieurs signes

Jamais un signe isolé

Un mécanisme commun

Qui explique leur association

Des causes multiples

À rechercher ensuite

Exemple — syndrome anémique

Signes : pâleur, asthénie, dyspnée d'effort, tachycardie → **mécanisme** : baisse de l'hémoglobine → **causes possibles** : carence martiale, hémorragie, hémolyse, insuffisance médullaire...

Syndrome ou maladie ?

Syndrome

- Regroupement de signes
- Mécanisme commun
- Plusieurs causes possibles
- Diagnostic **syndromique** : étape intermédiaire

Maladie

- Entité individualisée
- Cause, mécanisme, lésions et évolution propres
- Traitement souvent spécifique
- Diagnostic **étiologique** : aboutissement

L'exemple de Cushing

Syndrome de Cushing = hypercortisolisme, quelle qu'en soit la cause.

Maladie de Cushing = une seule cause : l'adénome hypophysaire corticotrope, sécrétant de l'ACTH.

Quelques grands syndromes cliniques

Syndrome anémique

Pâleur cutanéomuqueuse, asthénie, dyspnée d'effort, tachycardie

Syndrome méningé

Céphalées, vomissements, photophobie, raideur de nuque

Syndrome cholestatique

Ictère, prurit, urines foncées, selles décolorées

Épanchement pleural liquidien

Matité à la percussion, diminution ou abolition des vibrations vocales et du murmure vésiculaire

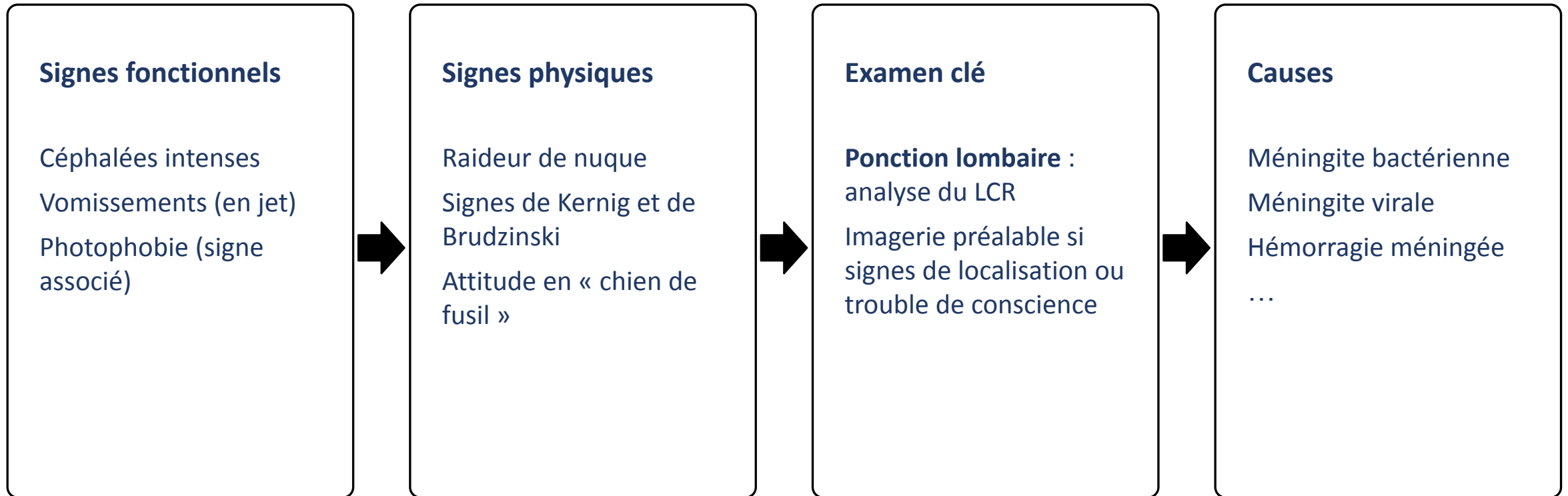
Insuffisance cardiaque droite

Hépatomégalie douloureuse, turgescence jugulaire, reflux hépato-jugulaire, œdèmes

Syndrome pyramidal

Déficit moteur, réflexes ostéotendineux vifs, signe de Babinski

Du syndrome à sa cause : le syndrome méningé



Trépied classique : céphalées + vomissements + raideur de nuque. La clinique pose le syndrome ; la **ponction lombaire** oriente vers sa cause.

Les syndromes biologiques

Syndrome	Anomalies biologiques	Causes fréquentes
Inflammatoire	CRP ↑, VS ↑, fibrinogène ↑, hyperleucocytose	Infections, maladies inflammatoires, cancers
Cytolyse hépatique	ASAT et ALAT ↑ (souffrance hépatocellulaire)	Hépatites virales, toxiques ou ischémiques
Cholestase	PAL ↑, γGT ↑, bilirubine conjuguée ↑	Obstacle biliaire, cholestase médicamenteuse
Hémolyse	Bilirubine libre ↑, LDH ↑, haptoglobine ↓, réticulocytes ↑	Hémolyse auto-immune, déficits enzymatiques

Un syndrome biologique est un **regroupement d'anomalies**, pas encore une cause.

Qu'est-ce qu'une maladie ?

Maladie : altération de la santé constituant une entité définie par une cause, un mécanisme, des lésions, une expression clinique et une évolution qui lui sont propres.

Étiologie

La cause :
pourquoi ?

Pathogénie

Le mécanisme :
comment ?

Lésions

Les altérations
anatomiques

Expression clinique

Symptômes et
signes

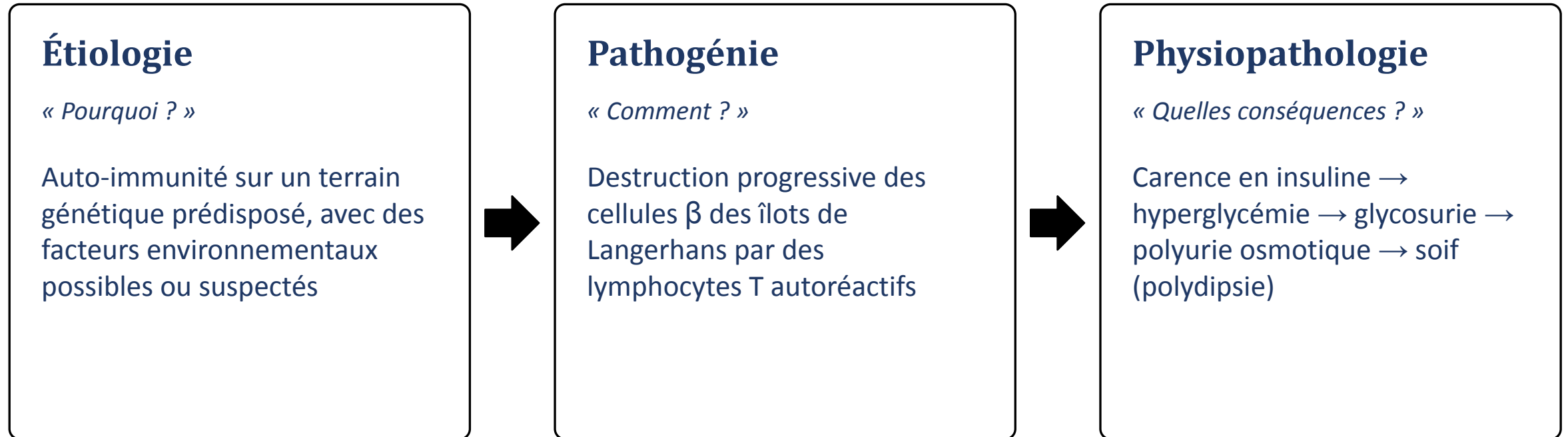
Évolution

Histoire naturelle,
pronostic

Quand la cause reste inconnue, la maladie est dite **idiopathique** : on la décrit alors par ses autres composantes.

Étiologie, pathogénie, physiopathologie

Exemple : le diabète de type 1



La **physiopathologie explique les signes** : c'est le pont entre la maladie et la sémiologie.

Qualifier l'origine d'une maladie

Idiopathique / essentiel

Idiopathique : cause inconnue.

Essentiel : forme primaire, sans cause secondaire identifiée.

Ex. : HTA essentielle

Secondaire

Cause identifiée.

Ex. : HTA secondaire à une sténose de l'artère rénale

Iatrogène

Provoqué par un traitement ou un acte médical.

Ex. : hypoglycémie sous insuline

Nosocomial

Infection acquise à l'hôpital, absente à l'admission.

Ex. : pneumopathie sous ventilation

Congénital

Présent à la naissance, génétique ou non.

Ex. : cardiopathie congénitale

Héréditaire

Transmis par les parents ; peut se révéler tard.

Ex. : polykystose rénale autosomique dominante

Le vocabulaire de l'évolution

Mode d'installation

Brutal (en quelques secondes ou minutes) · **rapide** (heures, jours) · **progressif, insidieux** (semaines, mois)

Durée

Aigu (jours) · **subaigu** (semaines) · **chronique** (au-delà de 3 mois en général) — durées indicatives, variables selon les maladies

Guérison

Disparition de la maladie ; « ad integrum » si sans séquelle

Complication

Événement nouveau, lié à la maladie ou au traitement, qui aggrave l'évolution

Séquelle

Trouble persistant après la guérison

Rémission

Diminution ou disparition temporaire des signes

Rechute

Réapparition des signes avant la guérison complète

Récidive

Nouvel épisode survenant après une guérison

La nosologie et la classification des maladies

Nosologie

Du grec *nosos* (maladie) : discipline qui **décrit, distingue et classe** les maladies.

Principaux axes de classement

- Par **appareil** ou organe (cardiologie, néphrologie...)
- Par **cause** (infectieuse, tumorale, génétique...)
- Par **mécanisme** (auto-immun, dégénératif, métabolique...)

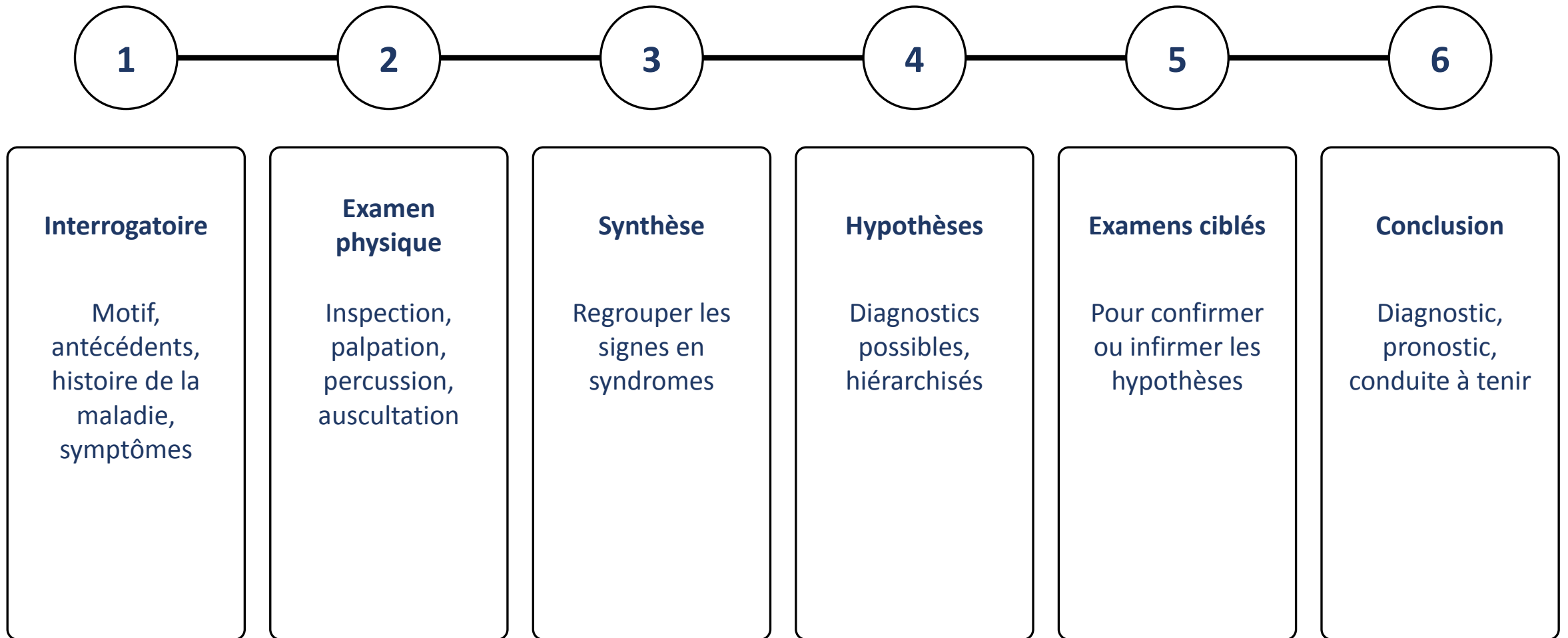
Usages : statistiques de morbidité et de mortalité, épidémiologie, recherche, organisation des soins.

CIM-11

Classification internationale des maladies, 11e révision (OMS)

En vigueur depuis le 1er janvier 2022 (source : OMS)

Les étapes de la démarche diagnostique



Les types de diagnostic

Diagnostic positif

« Qu'est-ce que c'est ? » Affirmer le syndrome ou la maladie sur des arguments cliniques et paracliniques

Diagnostic différentiel

« Qu'est-ce que cela pourrait être d'autre ? » Éliminer les affections donnant un tableau proche

Diagnostic étiologique

« Quelle en est la cause ? » Rechercher la cause du syndrome

Diagnostic topographique

« Où siège la lésion ? » Localiser l'atteinte (essentiel en neurologie)

Diagnostic de gravité

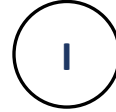
« Est-ce grave ? » Évaluer le retentissement et le degré d'urgence

Pronostic et vocabulaire épidémiologique

Pronostic

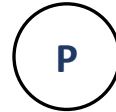
Prévision de l'évolution d'une maladie chez un patient donné.

- **Vital** : risque de décès
- **Fonctionnel** : risque de séquelles, de handicap
- **Évolutif** : risque de rechute, de complication



Incidence

Nombre de **nouveaux cas** sur une période, dans une population



Prévalence

Nombre **total de cas** (anciens et nouveaux) à un moment donné



Morbidité

Fréquence des maladies ou de l'état de maladie dans une population



Mortalité

Décès rapportés à **l'ensemble de la population**



Létalité

Décès rapportés aux **seuls malades**

Cas clinique : appliquer le vocabulaire

Homme de 65 ans, aux urgences : douleur de l'hypochondre droit, puis fièvre à 39,5 °C avec frissons, puis ictère cutanéomuqueux, en 48 heures.

1. Lire les signes

- **Fonctionnel** : douleur de l'hypochondre droit
- **Généraux** : fièvre, frissons
- **Physique** : ictère



2. Regrouper

- **Triade de Charcot** : douleur → fièvre → ictère
- **Biologie** : syndrome inflammatoire + cholestase



3. Nommer

- **Positif** : angiocholite aiguë
- **Différentiel** : cholécystite, hépatite, abcès du foie



4. Expliquer, évaluer

- **Étiologique** : lithiase de la voie biliaire principale, à confirmer par l'imagerie
- **Gravité** : sepsis, choc, insuffisance rénale ?

Pièges sémantiques fréquents

Fièvre ≠ hyperthermie

Fièvre : élévation **régulée** de la température, par élévation du point de consigne hypothalamique. Hyperthermie : élévation **non régulée** (coup de chaleur).

Dyspnée ≠ polypnée

Dyspnée : gêne respiratoire **ressentie** (symptôme). Polypnée : fréquence respiratoire **augmentée** (signe).

Aigu ≠ grave

« Aigu » qualifie la **durée** et le début ; « grave » qualifie le **danger**. Une maladie chronique peut être grave.

Rechute ≠ récurrence

Rechute : **avant** la guérison complète. Récurrence : nouvel épisode **après** la guérison.

Complication ≠ séquelle

La complication survient **au cours** de la maladie ; la séquelle **persiste après** la guérison.

Mortalité ≠ létalité

Mortalité : rapportée à **toute la population**. Létalité : rapportée aux **seuls malades**.

Points clés à retenir

1

La sémantique médicale fixe le **sens des mots** : elle fonde le raisonnement clinique.

4

Un **syndrome** regroupe des signes de mécanisme commun, sans préjuger de la cause.

2

Un terme médical se décompose : **préfixe + racine + suffixe**.

5

Une **maladie** se définit par sa cause, son mécanisme, ses lésions et son évolution.

3

Symptôme = subjectif (interrogatoire) ; **signe** = objectif (examen).

6

Diagnostic **positif** → **différentiel** → **étiologique** → **gravité**, puis pronostic.